

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0313

Paginas del documento: 8

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

s jurisdiccionales. A su vez, el uso de
ner tratamientos médicos y productos
a importante y controvertido en la

11

tas que ejercen tanto en el sistema público como en el sistema
privado de salud. Tras esto, los familiares realizan lo que se
denomina una “solicitud ciudadana” ya sea directamente al
hospital o al Servicio de Salud respectivo del cual dicho hospital
depende administrativamente.

Esta solicitud, en todos los casos revisados, obtuvo una res-
puesta negativa, arguyendo que dicho fármaco no se encontraba
dentro de su servicio de farmacia y que no existían recursos
extraordinarios para su adquisición. Posterior o paralelamente
los familiares realizan una solicitud directamente al FONASA.

Las respuestas del FONASA son estándares para cada solicitud
y consisten en lo siguiente:

2. Mientras que ante otras solicitudes la respuesta de FONASA
ha sido “su solicitud debe realizarla en el Ministerio de Sa-
lud, a través de una solicitud ciudadana o directamente en
la oficina de informaciones, reclamos y sugerencias (OIRS),
dado que FONASA no tiene la autoridad para comprar este
tipo de medicamentos, puede mencionarle a la Asistente
Social del Hospital si puede solicitar un auxilio extraordi-
nario al MINSAL.”¹⁴.
3. Otras respuestas de parte de las entidades aludidas han sido
“el fármaco Spinraza no estaba previsto en el formulario
nacional de medicamentos, no formaba parte de su arsenal
y que tampoco se consideraba su incorporación al sistema
de Garantías Explícitas de Salud o a la Ley N°20.850”¹⁵.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para conocer el comportamiento de las Cortes chilenas se realizó
una búsqueda online de los términos Spinraza y Nusinersen
dentro de la base de datos vLex y también en el compendio de
salud de las Cortes de Apelaciones y Suprema alojados en la
Base de Datos Jurisprudencial del Poder Judicial, analizándose
las causas disponibles falladas entre los años 2017 y 2022. Se
buscan dirigidamente aspectos como el tiempo entre la indi-
cación del fármaco y la sentencia, estado clínico del paciente
afectado, argumentos utilizados por recurridos y recurrentes
en las diferentes Cortes y, cuando se encontraba disponible,
el estado de cumplimiento de la sentencia.

RESULTADOS

Para determinar la oportunidad que ha otorgado la judiciali-
zación del acceso al Spinraza es necesario primero explicar la
vía administrativa que antecede a la presentación de la acción
de protección, la que en todas las causas judiciales revisadas
es muy similar. Tras el diagnóstico, los familiares obtienen una
receta médica que refiere que al paciente debe administrársele

Una vez que las familias obtienen la negativa ante la solicitud
de financiamiento es que recurren a las Cortes de Apelaciones
presentando acciones de protección en contra, ya sea del Hos-
pital que negó el medicamento, del Servicio de Salud al cual
pertenecer dicho centro hospitalario y en contra de FONASA.
Al igual que la vía administrativa inicial, los argumentos judi-
ciales para entablar esta acción de tutela son esencialmente
los mismos en las diferentes causas examinadas.

En relación con los fundamentos médicos que utilizan los
recurrentes, el principal consiste en que este fármaco es el
único aprobado para tratar la AME, entregando la posibilidad
de detener la progresión natural de la enfermedad y también
recuperar función motora, el que se encuentra aprobado por
FDA e ISP¹⁶. Esto implica que Spinraza detiene y revierte el
deterioro muscular y que su iniciación temprana puede mejorar
los resultados de la función motora en lactantes y niños con
atrofia muscular espinal, dando a los pacientes la posibilidad
de detener la progresión natural de la enfermedad¹⁷. Se indi-
ca que posee demostrada efectividad y es recomendado por
especialistas en la materia¹⁸. También se refiere que dicho
tratamiento es “esencial para su vida, ya que de lo contrario

aumentando la probabilidad de supervivencia. El segundo estudio, "CHERISH", concluye que la mejoría más grande en niños mayores de 6 meses se observa en aquellos más jóvenes y que comenzaron el tratamiento poco después de la aparición de los primeros síntomas ²¹.

De los 41 recursos de protección presentados, 39 de ellos se resolvieron por la Corte Suprema, siendo acogidos 32 de ellos, que consideraban a 35 pacientes, mientras que dos fueron acogidos en el tribunal de primera instancia no apelándose a dicha decisión. Así, de las 41 acciones de protección analizadas 34 (82.93%) fueron acogidas obligando los tribunales al Estado a financiar la adquisición del medicamento.

Examinando las 41 causas incluidas en este estudio resulta interesante mencionar que, en 30 de ellas, la receta médica indicando este medicamento fue emitida por médicos especialistas en neurología infantil desde sus consultas particulares o desde clínicas del sistema privado de salud, y en una minoría, 11 casos, el fármaco fue indicado por profesionales que ejercen sus labores en el sistema público de salud.

El comportamiento de las Cortes en relación con acoger o rechazar estas acciones de protección se resume de la siguiente forma:

- a. De las 39 acciones de protección que fueron conocidos por ambas Cortes, en 20 de ellos la Corte de Apelaciones acogió y la Corte Suprema ratificó dicho fallo
- b. En 13 de ellas la Corte de primera instancia rechazó la acción, siendo esta resolución revocada por la Corte Suprema, con ocasión del conocimiento de su apelación.
- c. Por otra parte, en 3 casos la Corte de Apelaciones acogió inicialmente la acción de protección, siendo posteriormente este fallo revocado en segunda instancia
- d. Finalmente, en 3 casos la Corte de Apelaciones rechazó la acción de protección, siendo este fallo ratificado en la Corte Suprema.

De los casos a los que se tuvo acceso, la distribución según grado la severidad de la patología es la siguiente:

- b. 19 pacientes presentan AME tipo 2, también con un caso de hermano tramitados en la misma causa.
- c. 10 de ellos presentan AME tipo 3 (un caso de hermanos en que uno es tipo 2 y el otro tipo 3 se tramitó en una causa única).

El promedio de edad de los pacientes al momento de ser resuelta la causa fue de 7,2 años con edades que fluctúan entre 11 meses a 21 años de vida.

Es relevante mencionar que los fallos de las Cortes se relacionaron con el nivel de severidad de la AME distribuyéndose de la siguiente forma:

- a. Todas las acciones de protección en que los pacientes su-

os en 14 causas) 13 ya se encontraban en fase de cirugía invasiva al momento del fallo.

protección presentadas por pacientes portadores de AME tipo 2, dos fueron acogidas en la Corte de Apelaciones sin que dicha resolución se apelara ante la Corte Suprema, mientras que de los 17 recursos de protección que conoció la Corte Suprema 13 fueron acogidos y 4 rechazados.

- c. Por último, de las 10 acciones de protección presentadas en favor de portadores de AME tipo 3 el comportamiento de las Cortes fue el siguiente: 3 casos fueron acogidos en ambas instancias, 4 fueron rechazadas por la Corte de Apelaciones, pero acogidas en el Tribunal Supremo, 2 fueron rechazadas en Apelaciones, pero se revocó dicho fallo en la Corte Suprema y en un caso la corte de primera instancia acogió la acción de protección siendo ésta posteriormente rechazada en segunda instancia.

lo que se tradujo en que el recurrido terminó contratando los servicios de una institución de salud privada donde finalmente se administró el fármaco al paciente²⁴.

En otra causa, la sentencia se cumplió casi a los 90 días que siguieron al fallo de la Corte Suprema, sin que se indicasen motivos para esto²⁰. En una tercera causa, luego de dos meses tras la sentencia, se indicó que la ejecución de la misma se encontraba “en proceso” sin otorgar mayores detalles²⁵. En otro caso, tras 4 meses y 11 días, aún no se había cumplido la sentencia. Finalmente, en un quinto caso, el recurrido indicó al tribunal “no contar con presupuesto disponible por el monto requerido, [por lo que] no es posible concretar la solicitud de compra”²⁶.

DISCUSIÓN

La judicialización del acceso a las prestaciones médicas es un fenómeno social que surge de la falta de acceso a tratamientos médicos o farmacológicos tanto en el subsistema de salud público como en el privado, lo que ha llevado a la ciudadanía a utilizar instrumentos legales en caso de violación percibida de su derecho a la salud. Es el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y la existencia de mecanismos de protección judicial de estos derechos lo que explica este fenómeno en Chile y en otros países de la región.

Queda meridianamente claro que el proceso de judicializar no ha permitido un acceso oportuno a este fármaco en los casos analizados. El tiempo entre la indicación médica del fármaco y el fallo de la Corte toma en promedio cerca de un año, lo que en este contexto puede determinar el pronóstico de los pacientes, ya que la evidencia disponible es enfática en la importancia de un inicio precoz del tratamiento, incluso en fase presintomática.

El promedio de edad de los pacientes al momento resolverse la causa fue de 7,2 años con edades que fluctúan entre 11 meses a 21 años de vida. Respecto a esto podemos mencionar el estudio “ENDEAR” (2017), clave para la aprobación de Spinraza por la FDA, incluyó sólo pacientes con AME tipo 1 menores de 6 meses. La edad promedio para la primera dosis fue de 163 días de vida y excluyó a pacientes con insuficiencia respiratoria al momento de ser reclutados. En sus conclusiones este estudio señala que el inicio precoz es fundamental para maximizar el beneficio de este medicamento²⁷.

El siguiente estudio relevante es el “CHERISH” (2018) incluyó a 126 niños con AME de aparición posterior a los 6 meses, enfocado en pacientes con AME tipo 2. Mostró mejoría en un 57% de los tratados con Nusinersen en comparación con el 26 % en el grupo de control. tuvieron una mejoría en su función motora. Los participantes, de entre 2 y 12 años, tenían la capacidad de sentarse solos, pero no de caminar independientemente. Se excluyeron pacientes con insuficiencia respiratoria, usuarios de Bipap y portadores de gastrostomía²⁸.

En 2021 se publica el estudio “EMBRACE”, que incluyó a 21 niños con AME de inicio antes de los 6 meses y otro grupo

lcanzando hitos motores tras recibir
on pacientes con síntomas de AME
a primera semana de vida, como así
ueostomía o en ventilación mecánica

≥16 horas diaria²⁹.

El cuarto estudio relevante es el “NURTURE” que se publica en 2019 antes de que se fallaran 32 de las 41 causas analizadas en este estudio. Este incluyó 25 niños con diagnóstico genético de AME, pero sin presentar aún síntomas, iniciando la administración de Nusinersen en este estadio. Al último control de seguimiento los pacientes tenían 34,8 meses de vida (rango de 25,7 a 45,4 meses), habiendo superado todos la edad de aparición de síntomas de AME tipo 1 y tipo 2. Ninguno había fallecido y ninguno se encontraba en ventilación mecánica permanente ni había requerido traqueostomía. Los 25 participantes lograron sentarse sin apoyo, 23 lograron caminar con ayuda y 22 lograron caminar de forma independiente³⁰.

Al analizar la información procedente queda en evidencia que uno de los puntos críticos para que el medicamento sea efectivo es la precocidad en el inicio del tratamiento, encontrándose mejor evidencia antes de los 6 meses de edad, y mucho mejor aún antes del inicio de los síntomas. El proceso de judicialización va directamente en contra de esto, pues la edad en promedio en que los niños acceden al medicamento por esta vía es de 7,2 años y por otro lado el proceso toma en promedio más de 300 días.

Profundizando más en este aspecto, se puede mencionar que las Cortes tienden a acoger las acciones de protección mientras más grave sea el caso y peor la condición clínica del paciente, incluyendo en este estudio 16 pacientes que ya se hallaban en ventilación mecánica de forma prolongada (promedio 1.468 días en dicha condición con un rango de 251 a 2385 días) al momento del fallo. Esta decisión se fundamenta en considerar que la vida de los pacientes se encontraba en peligro inminente por lo que acoger la acción de protección evitaba la vulneración de este derecho fundamental. Sin embargo, desde el punto de vista clínico esta decisión es cuestionable. Respecto al beneficio de administrar el Nusinersen a este grupo de pacientes existe publicada una revisión del año 2022 que analiza los estudios científicos realizados en los últimos 5 años que incorporan a pacientes que ya se encontraban en ventilación mecánica no invasiva al momento de recibir Nusinersen. La revisión incluye en total 172 pacientes y los resultados son los siguientes: 122/172 (70,9%) de los pacientes mantuvieron idénticas necesidades de soporte ventilatorio tras el tratamiento; 13/172 (7,5%) de los pacientes presentaron una reducción en sus necesidades de soporte ventilatorio y un paciente de los 172 (0,6%) pudo ser retirado del ventilador mecánico no invasivo tras un seguimiento de 24 meses. Por lo que concluye que la evidencia sugiere que entre los niños con AME, que están en soporte respiratorio mecánico, en el momento del tratamiento basado en genes, solo unos pocos podrían ser retirados o verían reducidas sus necesidades de ventilación mecánica³¹.

En las sentencias, la Corte Suprema indica que “es preciso

extraordinariamente costoso debiera riterios clínicos, administrándolo a ún la mejor evidencia disponible es cio. En este sentido, el Ministerio de Sanidad español elaboró un protocolo para la administración de Nusinersen, en el que para la AME tipo I son criterios de exclusión la necesidad de ventilación invasiva permanente y las situaciones clínicas muy avanzadas que, a juicio clínico, no sean reversibles y en las que no se espera un beneficio con la administración del tratamiento³⁴.

Evitar interpelar a la justicia pudiera facilitar que el Estado negocie mejores precios con el laboratorio productor facilitando su adquisición. Implicaría ahorro de tiempo y recursos de los tribunales, evitaría perder valioso tiempo en que el avance de la enfermedad sella el pronóstico de los pacientes. Lo anterior, junto con la elaboración de estrictos protocolos médicos que aseguren que la administración del fármaco se base únicamente en criterios clínicos pudiera tender a una distribución más eficiente de recursos y evitaría tratamientos tardíos e infructuosos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

11. Lamprea E. The judicialization of health care: A Global South perspective. *Annu Rev Law Soc Sci.* 2017;13:18.1-18.19.
12. Constitución Política de la República de Chile. 1980
13. Corte Suprema, Santiago. Elvira Jazmín Fuentealba Castro por Ignacio León Alfaro Fuentealba/Hospital Las Higueras de Talcahuano y Otro. 2018 Nov 28; Rol: 22.960-2018 (causa 7-11).
14. Corte de Apelaciones de Santiago. Ramírez/Fondo Nacional de Salud. 2020 Jan 9; Rol: 77485-2019.
15. Corte de Apelaciones de San Miguel, Santiago. Esparza/Fondo Nacional de Salud. 2021 Apr 7; Rol: 10440-2020.
16. Corte de Apelaciones de San Miguel, Santiago. Flores/Fonasa. 2019 Jan 18; Rol: 7820-2018.
17. Corte de Apelaciones de Chillán. Ortiz/Fonasa. 2019 May 8; Rol: 257-2019.
18. Corte de Apelaciones de Santiago. Ramírez/Fondo Nacional de Salud. 2020 Jan 9; Rol: 77485-2019.
19. Corte de Apelaciones de Concepción. Daniela Díaz Hernández/Servicio de Salud de Concepción y otros. 2018 Jul 18; Rol: 3822-2018.
20. Corte de Apelaciones de Concepción. Sergio Crisosto Hidalgo y Ester Medel Pérez en favor de Catalina Crisosto Medel con Fonasa y otros. 2019 Feb 25; Rol: 10421-2018.
21. Corte de Apelaciones de Santiago. Ramírez/Fondo Nacional de Salud. 2020 Jan 9; Rol: 77485-2019.
22. Corte de Apelaciones de La Serena. Flores/Fonasa. 2019 Oct 28; Rol: 945-2019.

ol: 511-2019.

de San Miguel. Briceño/Infante. 2018
7.

25. Corte de Apelaciones de Santiago. Vargas/Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana. 2020 Feb 10; Rol: 85106-2019.
26. Corte de Apelaciones de San Miguel. Moya/Fonasa. 2019 Apr 26; Rol: 500-2019.